VINÍCIUS GONÇALVES NOGUEIRA

ACEITABILIDADE E DISPOSIÇÃO A PAGAR POR UMA VACINA HIPOTÉTICA CONTRA O HIV NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UM ESTUDO TRANSVERSAL

MACAÉ

2024

VINÍCIUS GONÇALVES NOGUEIRA

ACEITABILIDADE E DISPOSIÇÃO A PAGAR POR UMA VACINA HIPOTÉTICA CONTRA O HIV NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado ao Curso de Farmácia do Instituto de Ciências Farmacêuticas da UFRJ, como requisito para obtenção do título de farmacêutico.

Orientadora: Prof. Dra. Isabella Piassi Dias Godói

MACAÉ

2024

CIP - Catalogação na Publicação

N778
Nogueira, Vinícius Gonçalves
Aceitabilidade e Disposição a Pagar por uma vacina hipotética contra o HIV no Estado do Rio de Janeiro: um estudo transversal / Vinícius Gonçalves Nogueira - Macaé, 2024.
41 f.

Orientador(a): Isabella Piassi Dias Godói.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Farmacêuticas, Bacharel em Farmácia, 2024.

1. HIV. 2. Vacina. 3. Síndrome de imunodeficiência adquirida - -- Prevenção e controle. I. Godói, Isabella Piassi Dias, orient. II. Título.

CDD 615

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a)
Biblioteca Central do Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé
Bibliotecário: Anderson dos Santos Guarino CRB7 – 5280

VINÍCIUS GONÇALVES NOGUEIRA

ACEITABILIDADE E DISPOSIÇÃO A PAGAR POR UMA VACINA HIPOTÉTICA CONTRA O HIV NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Trabalho de conclusão de curso (TCC) defendido e aprovado como requisito para obtenção do título de farmacêutico.

Macaé, 25 de Junho de 2024.

Comissão avaliadora:

Profa. Dra. Isabella Piassi Dias Godói (Presidente da Banca)
CM UFRJ-Macaé
http://lattes.cnpq.br/9235375090080643

Profa. Dra. Caroline Addison Carvalho Xavier De Medeiros
CM UFRJ-Macaé
http://lattes.cnpq.br/2982271986555450

Profa. Dra. Isabela Barboza da Silva Tavares Amaral
Instituto de Enfermagem – UFRJ Campus Macaé
http://lattes.cnpq.br/8761608397572287

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus, que permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida, mesmo com tantas dificuldades, não deixou de estar ao meu lado, me apoiando e me dando forças mesmo nos momentos mais difíceis ao longo desses anos.

Aos meus pais, que são minha base, e batalharam para me dar a condição de chegar aonde estou. Meus exemplos de vida, e hoje sou o que sou graças a eles.

Agradeço aos meus amigos, que serviram como apoio emocional em tantas dificuldades ao longo da vida, e escape de todo o estresse, e em especial aqueles que contribuíram para que a pesquisa acontecesse.

Por fim, mas não menos importante, a minha orientadora, por acreditar em mim e neste trabalho, e a todos os professores do Instituto de Ciências Farmacêuticas – UFRJ Macaé pelos ensinamentos durante toda esta caminhada.

ABSTRACT

Introduction: The Human Immunodeficiency Virus (HIV) is one of the biggest public health challenges that communities around the world still face, and to date there is no vaccine available for its prevention. In Brazil, the State of Rio de Janeiro has stood out in the epidemiological scenario of this disease, being an important state to conduct a Willingness to Pay (DAP) analysis, as it represents a relevant consumer market for a future vaccine against this disease. **Objective:** To analyze the DAP of residents of the State of Rio de Janeiro for a hypothetical vaccine against HIV, as well as its acceptability. **Methods:** A cross-sectional study was carried out to evaluate the acceptability and DAP of the population of the State of Rio de Janeiro for a hypothetical vaccine against HIV with 70% efficacy. The study was carried out in the second half of 2023, involving the application of a questionnaire. The research project linked to this study was approved by the Ethics and Research Committee of the Federal University of Pará (CAAE 12943619.5.0000.8607). **Results and Discussion:** 600 individuals were interviewed, and the acceptability of 77.2% for the hypothetical HIV vaccine was verified. Among the 600 interviewees, 53.5% were female, 58.2% of the sample were working at the time of the interview and 65.5% had health insurance. Furthermore, it was observed that 61.5% of the participants had completed high school with a level of education, and 20.3% declared a per capita family income between three and minimum ranges. For the DAP analysis, 452 participants were eligible, who declared a maximum amount to pay of R$400.00 for a hypothetical vaccine in the study, a higher amount than that found in another survey (R$200.00) previously carried out in the State of Pará, and which involves the same methodological conditions as this work and under the guidance of the same teacher. Additionally, it is noteworthy that the evaluation of the variables income, education, health plan and gender showed a statistical correlation (p-value < 0.05) with the value of willingness to pay for the hypothetical 70% effective vaccine against HIV. Furthermore, it is noteworthy that a study carried out in 2019 in the North of the country obtained an acceptability for the hypothetical HIV vaccine of 94%, compared to 77.2% declared by the public in the State of Rio de Janeiro. An aspect that may be related to the increase in vaccine hesitancy observed during and after the COVID-19 pandemic not only in the State of Rio de Janeiro, but throughout Brazil. **Conclusion:** Economic studies, such as DAP, can contribute to discussions applied to the pricing of future vaccines, particularly for an anti-HIV immunobiological in countries like Brazil, with more than 5,000 municipalities spread across regions with diverse characteristics and challenges (socioeconomic, epidemiological and cultural). Factors such as acceptability and socioeconomic profile must be better evaluated considering the private market, as well as the public context for the implementation of a vaccine and its pricing.

Keywords: Acceptability; Willingness to pay; HIV; vaccine; contingent valuation; Brazil.

RESUMO

Introdução: O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um dos maiores desafios de saúde pública que as comunidades em todo o mundo ainda enfrentam, e até o momento não há vacina disponível para sua prevenção. No Brasil, o Estado do Rio de Janeiro tem se destacado no cenário epidemiológico desta doença, sendo um estado importante para se conduzir uma análise de Disposição a Pagar (DAP), uma vez que representa um relevante mercado consumidor para uma futura vacina contra este agravo. **Objetivos:** Analisar a DAP dos residentes do Estado do Rio de Janeiro por uma vacina hipotética contra o HIV, bem como sua aceitabilidade. **Métodos:** Foi realizado um estudo transversal para avaliar a aceitabilidade e DAP da população do Estado do Rio de Janeiro para uma hipotética vacina contra o HIV com 70% de eficácia. O estudo foi realizado no segundo semestre de 2023, envolvendo a aplicação de questionário. O projeto de pesquisa vinculado a este estudo foi aprovado por Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Pará (CAAE 12943619.5.0000.8607). **Resultados e Discussão:** Foram entrevistados 600 indivíduos, sendo verificado a aceitabilidade de 77,2% para a vacina hipotética contra o HIV. Entre os 600, a porcentagem de mulheres foi de 53,5% dentre os entrevistados, 58,2% da amostra estava trabalhando no momento da entrevista, e 65,5% possuíam plano de saúde. Ademais, foi observado que o nível de escolaridade de ensino médio completo foi de 61,5% dos participantes, e 20,3% dos participantes declararam renda per capita familiar entre 3 e 5 salários mínimos. Para a análise de DAP, foram elegíveis 452 participantes, que declararam um valor máximo a pagar de R$ 400,00 para uma vacina hipotética do estudo, valor superior ao encontrado em outra pesquisa (R$ 200,00) realizado previamente no Estado do Pará, e que envolvendo as mesmas condições metodológicas deste trabalho e sob a orientação da mesma professora. Adicionalmente, destaca-se que a avaliação das variáveis renda, escolaridade, plano de saúde e gênero apresentaram correlação estatística (valor-p < 0,05) com o valor de disposição a pagar pela vacina hipotética de 70% de eficácia contra o HIV. Além disso, ressalta-se que estudo realizado, em 2019, no Norte do país obteve uma aceitabilidade para a vacina hipotética contra o HIV de 94%, comparado com 77,2% do declarado pelo público do Estado do Rio de Janeiro, aspecto que pode estar relacionado com o aumento da hesitação vacinal observada durante e após a pandemia de COVID-19 não apenas no Estado do Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. **Conclusão:** Estudos econômicos, como o de DAP, podem contribuir para discussões aplicadas à precificação de futuras vacinas, particularmente para um imunobiólogico anti-HIV em países como o Brasil, com mais de 5.000 municípios espalhados por regiões com características diversas e desafios (socioeconômicos, epidemiológicos e culturais). Fatores como aceitabilidade e perfil socioeconômico devem ser melhor avaliados considerando o mercado privado, bem como o contexto público para a implementação de uma vacina e sua precificação.

Palavras-chave: Aceitabilidade; Disposição a pagar; HIV; vacina; contingente avaliação; Brasil.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Porcentagem acumulada de DAP para uma vacina hipotética contra o HIV de acordo com os valores máximos reportados 25

Figura 2. Boxplots indicando a disposição a pagar por uma vacina hipotética contra o HIV de acordo com a faixa de renda familiar *per capita* 27

Figura 3. Boxplots indicando a disposição a pagar por uma vacina hipotética contra o HIV de acordo com o nível de escolaridade 27

LISTA DE FIGURAS

Tabela 1. Características dos entrevistados (n=600) 23

Tabela 2. Análise univariada associada para cada variável 26

LISTA DE ABREVIAÇÕES

DAP	Disposição a Pagar
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana
SIDA	Síndrome de Imunodeficiência Adquirida

SUMÁRIO

1. Introdução 12
2. Justificativa 17
3. Objetivos 18
3.1. Gerais 18
3.2. Específicos 18
4. Métodos 19
4.1. Instrumento e coleta de dados 19
4.2. Local do estudo e coleta de dados 20
4.3. Critérios de seleção e inclusão 21
4.4. Análise de dados 21
4.5. Aspectos éticos 22
5. Resultados 23
5.1. Características da população 23
5.2. DAP para uma hipotética vacina contra o HIV 24
6. Discussão 28
7. Conclusão 31
8. Referências 33
9. Apêndice 39

1. INTRODUÇÃO

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) pertence ao gênero *Lentivirus* e à família *Retroviridae* (ICTV, 2009). Este vírus é responsável por desencadear a depressão imunológica ao atacar e infectar células da membrana glicoprotéica (linfócitos T CD4 +), bem como atingir macrófagos e linfócitos T auxiliares (Melo et al., 2008; Silva, 2018). Uma vez infectados, os indivíduos na fase aguda podem desenvolver sintomas que vão desde uma síndrome semelhante à gripe, até uma doença semelhante à mononucleose, febre e dor de cabeça. Também é importante observar o possível surgimento de "infecções oportunistas", incluindo a tuberculose (Brasil, 2023a). Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (2022) e o Ministério da Saúde do Brasil (2023), esse vírus é transmitido sexualmente por meio do contato sexual desprotegido (oral, vaginal, anal) com uma pessoa infectada. A transmissão também pode ocorrer de mãe para filho durante a gravidez, especialmente, durante o primeiro trimestre, parto ou amamentação, bem como através do compartilhamento de agulhas infectadas, objetos pontiagudos e transfusões de sangue contaminado (Gürtler et al., 2016; FIOCRUZ, 2022; Brasil, 2023a).

O vírus HIV é classificado em dois tipos: HIV-1 e HIV-2, sendo este último menos patogênico em comparação ao primeiro, e sendo endêmico, principalmente, na África Ocidental (Sharp & Hahn, 2011; Gürtler et al., 2016; Reeves et al., 2021). Além disso, há registros indicando que o HIV-1 está associado a um maior número de infecções em todo o mundo, sendo este o mais virulento (Nyamweya et al., 2013). Um aspecto clínico importante a ser considerado para esta infecção é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), do inglês *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), que representa um estágio crítico da infecção com destruição dos linfócitos T CD4+, tornando o organismo mais suscetível a outras doenças (Février, Dorgham & Rebollo, 2011; Brasil, 2023a). Estigmas e preconceitos associados a indivíduos soropositivos, infelizmente ainda são verificados, como se chamar a doença como "câncer gay", uma vez que muitos casos foram registados em indivíduos do sexo masculino e homossexuais, especialmente, fora da África (Greenwood et al., 2021; Anderson & Felton, 2022).

Desde 1981, quando esta infecção por retrovírus foi oficialmente registada e reconhecida, milhares de indivíduos foram infectados, com uma prevalência notável na África Subsariana, com, aproximadamente, 20,6 milhões de infecções, bem como na Ásia e no Pacífico, com cerca de 5,7 milhões de casos notificados em 2020 (UNAIDS, 2021).

Estima-se que até o final de 2022, aproximadamente, 39 milhões de indivíduos em todo o mundo tenham sido infectados (WHO, 2023). No Brasil, uma das primeiras mortes associadas ao HIV foi a do estilista Markito, falecido em 1983 (Laurindo & Teixeira, 2015; Senado Federal, 2023). Segundo dados publicados pelo Ministério da Saúde, desde o início da epidemia até o final do século XX, o país contava com cerca de 279 mil indivíduos infectados pelo HIV (UNAIDS, 2022). Esta infecção representa muitos desafios à saúde pública do país, considerando seus diversos aspectos associados à morbidade, mortalidade e à alocação de recursos públicos para estratégias de prevenção e tratamento dos infectados (Nascimento et al., 2021). No Estado do Rio de Janeiro, mais de 39 mil indivíduos foram registrados como portadores deste retrovírus até o final do século XX e, no final de 2022, esse número aumentou para mais de 141 mil (UNAIDS, 2022). Além disso, estimativas do Ministério da Saúde revelaram que há mais de um milhão de pessoas vivendo com HIV no Brasil (UNAIDS, 2022; CNN Brasil, 2023a). No entanto, houve um declínio no número de casos de HIV no país, com um total de 40.880 casos notificados em 2021, e 16.703 novas infecções foram notificadas em Junho de 2022, representando uma diminuição de 11,1% (Agência AIDS, 2023). Segundo o Ministério da Saúde, a região Sudeste registrou 5.809 novos casos de HIV até junho de 2023, com um total de 20.237 casos registrados em todo o país, tendo o Sudeste representando 31,06% dos casos no Brasil (Brasil, 2023b).

Em 2022, ocorreram, aproximadamente, 630.000 mortes por doenças relacionadas com a SIDA em todo o mundo, uma diminuição significativa em comparação com 2010, onde ocorreram aproximadamente 1,3 milhões de mortes (UNAIDS, 2022). Além disso, ainda de acordo com o UNAIDS Brasil, desde 2010, a mortalidade relacionada à AIDS diminuiu aproximadamente 55% entre mulheres e meninas (de 15 a 24 anos) e 47% entre homens e meninos (de 15 anos ou mais) no país, o que é encorajador (UNAIDS, 2022). Adicionalmente, vale destacar que entre o final de 2022 e junho de 2023, o total de novos casos de AIDS no Brasil foi de 16.281, sendo o Rio de Janeiro responsável por 11,08% desses casos, correspondendo a 1.804 novos casos notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (Brasil, 2023b). Segundo dados do Painel de Indicadores de HIV do Estado do Rio de Janeiro (2024), a taxa de detecção do vírus (número de casos de HIV/população x 100 mil habitantes) também diminuiu nos últimos anos, passando de 0,457 em 2017 para 0,394 em 2019, e 0,372 em 2021. No entanto, o perfil de indivíduos infectados é maior entre os homens, com particular ênfase nos homossexuais (SESRJ, 2024).

Segundo o Ministério da Saúde, entre 2018 e 2022, entre os 100 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes que tiveram o maior número de registros de infecção pelo HIV, dois deles estão localizados no Estado do Rio de Janeiro, e estão nas posições 11º (Queimados) e 15º (Magé) (Brasil, 2023b). Além disso, em 2022, o Estado do Rio de Janeiro ficou em sétimo lugar entre os Estados do Brasil com as maiores taxas de detecção de AIDS (Brasil, 2023b). Esses dados demonstram a importância da infecção no estado, podendo contribuir e/ou influenciar na DAP por uma vacina voltada à prevenção desta doença.

Até o momento, não há cura ou vacina para o HIV. No entanto, ao longo dos anos, muitas terapias isoladas e em combinação foram desenvolvidas para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus. A Terapia Antirretroviral Combinada (TARV) visa inibir a replicação do HIV, melhorar a sobrevida do paciente e retardar a progressão da imunodeficiência, tornando-a uma terapia eficaz (Esther et al., 2013; Supervie et al., 2014; Trickey et al., 2017; Nascimento et al., 2021). Além disso, em 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil aprovou o primeiro medicamento injetável contra o HIV no Brasil, o Cabotegravir, que inclui Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e tem ação de longa duração. Como resultado, oferece vantagens em relação aos comprimidos orais com eficácia 69% maior (G1, 2023a; Brasil, 2023c).

Além disso, no domínio da imunização, a vacina do estudo MOSAICO (HPX3002/HVTN706) encontra-se atualmente na Fase III, avaliando o potencial de quatro doses da vacina para a prevenção do HIV, com foco na população masculina e nos indivíduos transexuais (que não se identificam com seu gênero biológico) (Clinical Trials, 2023; HIV VACCINE, 2023). Em 2021, o estudo contava com aproximadamente 3.900 homens cisgêneros e indivíduos transgêneros que fazem sexo com homens cisgêneros e/ou indivíduos transgêneros, uma população considerada de maior vulnerabilidade para adquirir o HIV. O estudo envolve mais de 50 países, incluindo Argentina, Brasil, Itália, México, Peru, Polônia, Espanha e Estados Unidos (Clinical Trials, 2023; HIV VACCINE, 2023). Publicações de setembro de 2023 indicam que o ensaio ainda está recrutando voluntários (Clinical Trials, 2023).

No Brasil, um novo medicamento e/ou vacina precisa passar por diferentes tipos de órgãos e comitês reguladores antes de poder ser comercializado. Um novo medicamento deverá seguir os critérios e protocolos determinados pela ANVISA, e ser registrado para

comercialização. É importante ressaltar que após o cadastro, as empresas solicitam a precificação do produto. A responsabilidade dessa etapa é da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), que avalia os preços atuais do produto a ser precificado no Brasil, considerando preços estabelecidos em outros países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Austrália e França. O preço estabelecido no Brasil não pode ser superior ao menor preço adotado para o mesmo produto nesses países (Brasil, 2020; Godói et al., 2017; Muniz Junior et al., 2019; Godói et al., 2021). Após a aprovação da ANVISA e a precificação pela CMED, as empresas farmacêuticas podem solicitar a incorporação dessa tecnologia ao Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (CONITEC) a responsabilidade de avaliar esta solicitação. Esta comissão auxilia o Ministério da Saúde em avaliações que incluem a viabilidade de incorporação de uma nova tecnologia, exclusão de uma já existente ou modificação (Brasil, 2023d; Sarmento et al., 2019; Godói et al., 2021).

Vale ressaltar que o sistema público de saúde brasileiro é baseado em princípios fundamentais, incluindo universalidade, equidade e abrangência dos serviços disponíveis para uma população de mais de 200 milhões de habitantes (Caires de Souza et al., 2014; IBGE, 2024a). No contexto da prevenção de doenças infecciosas, o Brasil possui um dos programas mais abrangentes, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), instituído desde 1973. O PNI tem contribuído para a redução da morbimortalidade por infecções no país, alcançando uma série de marcos incluindo a erradicação da varíola em 1973, e da poliomielite em 1989 (Brasil, 2024a). Ao longo de seus mais de 50 anos de atuação, o PNI disponibilizou para toda a população aproximadamente 20 vacinas de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação (Brasil, 2024a; Brasil, 2024b). Recentemente, durante a pandemia do coronavírus, o PNI forneceu mais 585,6 milhões de doses aos brasileiros, contribuindo para uma redução de 96,44% das mortes causadas pelo vírus (Brasil, 2023e; Brasil, 2023f; Araújo & Fernandes, 2022).

Com a perspectiva da comercialização de uma hipotética vacina contra o HIV, é importante avaliar a Disposição a Pagar (DAP) de uma nova vacina para ajudar a orientar as discussões nacionais sobre preços, o que é relevante para o contexto de tomada de decisão dos gestores e economistas da saúde, com o objetivo de fornecer percepções e dados sobre a gama de valores associados a um produto (Haab & McConnell, 2003; Godói et al., 2017; Sarmento et al., 2019; Athie et al., 2021; Godói et al., 2021; Nascimento et al., 2021). Os estudos de DAP permitem que os tomadores de

decisão avaliem um valor pontual, faixas de valores ou a resposta positiva ou negativa a um valor apresentado, contribuindo para uma melhor percepção das preferências de um indivíduo associado à precificação sobre tecnologias, serviços e programas em saúde (Habb & McConnell, 2003; Godói et al., 2017; Athie et al., 2021; Godói et al., 2021; Nascimento et al., 2021). Além disso, os economistas consideram a avaliação contingente como um método consolidado no processo de avaliação econômica dos recursos ambientais e de saúde (Habb & McConnell, 2003).

Estamos cientes de que foi realizado um estudo no Estado do Pará, que revelou uma aceitabilidade considerável entre os entrevistados (94%) para uma hipotética vacina contra o HIV com 70% de eficácia (Nascimento et al., 2021). Os autores demonstraram que os participantes da região Norte do Brasil tinham uma DAP de R$200, e 40,8% afirmaram que pagariam entre R$75,00 e R$300,00 por uma vacina hipotética (Nascimento et al., 2021). Paralelamente, outros estudos utilizando esta técnica foram realizados nos Estados Unidos (Lally et al., 2006) com indivíduos encarcerados como o público da DAP, Uganda (Bichai et al., 2004) e Canadá tendo como público-alvo usuários de drogas (Fleming et al., 2020).

O Brasil sendo um país marcado por diferentes características, demandas e desafios relacionados à renda, à epidemiologia e aos orçamentos disponíveis, bem como à compreensão e aceitação das vacinas, acreditamos que é importante realizar tais análisesem outros Estados do Brasil, especialmente dado ao interesse e prioridade com a erradicação do HIV no Brasil.

Consequentemente, procuramos preencher essa lacuna de informação elucidando o valor máximo da DAP para uma hipotética vacina contra o HIV no Estado do Rio de Janeiro. Este Estado foi escolhido para estudo de acompanhamento por se destacar entre osprincipais Estados do país, associado à sua localização na principal região do Brasil, tanto do ponto de vista socioeconômico quanto epidemiológico para esta condição.

2. JUSTIFICATIVA

A infecção associada ao HIV é considerada um dos principais desafios da saúde pública, considerando seu contexto clínico, econômico e epidemiológico, não apenas no Brasil, como no mundo, Neste contexto, faz-se necessário implementações de novas tecnologias eficazes (vacina) para minimizar os inúmeros registro de óbitos ocasionados por este agravo. Ressaltando que independente da aprovação de uma vacina contra este retrovírus, faz-se necessário esforços no contexto dos cuidados e sensibilização da população envolvendoas estratégias de prevenção.

Diante do apresentado, este é o primeiro estudo associado a avaliação econômica de disposição a pagar de consumidores no sudeste do Brasil, por uma vacina hipotética contra o HIV. Adicionalmente, torna-se de suma importância a realização de estudos econômicos com a finalidade de melhor avaliar e compreender as novas tecnologias, sua aceitabilidade e seu valor na perspectiva de potenciais consumidores. Além disso, destaca-se a relevância de reflexões e debates não apenas associado à precificação de futuras vacinas mas, principalmente, referente à aceitabilidade destas, tema a ser considerado como um desafio para a saúde pública não apenas no Brasil como em diversos países, em especial, após o período da pandemia.

3. OBJETIVOS

3.1 Gerais

Demonstrar a disposição a pagar do consumidor do Estado do Rio de Janeiro por uma vacina hipotética contra o HIV.

3.2 Específicos

- Contribuir para as discussões e reflexões sobre a precificação de uma futura vacina hipotética contra o HIV no Brasil;
- Demonstrar a aceitabilidade de uma futura vacina contra o HIV no Estado do Rio de Janeiro.

4. MÉTODOS

O presente estudo utilizou o método de análise de valoração contingente para estimar a DAP dos consumidores do Estado do Rio de Janeiro para uma hipotética vacina contra o HIV. Conforme mencionado anteriormente, esta técnica permite estimar o valor máximo que os indivíduos estão dispostos a pagar por uma intervenção clínica, tecnologia ou serviço, hipotético ou não hipotético. É realizado por meio de questionário para quantificar o valor monetário (por exemplo, valor específico, faixa de valores) e auxiliar nas discussões e processos de tomada de decisão em relação à precificação de produtos de saúde (Haab & McConnell, 2003; Godói et al., 2017; Muniz Junior et al., 2019; Sarmento et al., 2019; Godói et al., 2021; Nascimento et al., 2021).

4.1 Instrumento e coleta de dados

O instrumento de pesquisa (questionário) foi previamente desenvolvido e utilizado no estudo de Nascimento et al. (2021) para estimar a DAP para uma vacina hipotética contra o HIV na região Norte do Brasil. A mesma professora (IPDG) coordenou os estudos, anteriormente citados, e realizou outras publicações nesta área (Godói et al., 2017; Muniz Junior et al., 2019; Sarmento et al., 2019; Athiê et al., 2021; Godói et al., 2021; Nascimento et al., 2021; Costa et al., 2022; Torres et al., 2024). O questionário contém informações sobre a doença e a tecnologia proposta, incluindo sua eficácia e possíveis efeitos adversos, além de dados epidemiológicos. Inclui questões abertas e fechadas (Haab & McConnell, 2003; Godói et al., 2017; Muniz Junior et al., 2019; Sarmento et al., 2019; Godói et al., 2021; Nascimento et al., 2021).

O questionário foi dividido em cinco partes para auxiliar na organização e entendimento: (1) perguntas para avaliar o conhecimento dos participantes sobre o HIV; (2) texto informativo abordando a infecção, a vacina e alternativas de prevenção; (3) questões para avaliar a compreensão dos participantes sobre as informações apresentadas; (4) escolha discreta, jogo de lances e perguntas abertas; (5) coleta de informações socioeconômicas. Na seção quatro, a escolha discreta refere-se a descobrir se o participante está disposto a pagar R$200,00 (US$39.68) por uma vacina hipotética contra o HIV (dose única). O jogo de lances apresentava diversos valores ao participante para avaliar a faixa de valores que ele estaria disposto a pagar pela vacina hipotética. A questão aberta avaliou o valor máximo da DAP para o produto do estudo. O questionário em questão está disponibilizado no apêndice, para fins ilustrativos.

O valor de R$200,00 para a hipotética vacina contra o HIV foi baseado no valor proposto no estudo anterior realizado na região Norte do Brasil (Nascimento et al., 2021), juntamente com uma inflação de, aproximadamente, 4% de janeiro a novembro de 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Banco Central, 2023; IBGE, 2023). Além disso, estimou-se que a vacina hipotética tinha eficácia de 70%, mesmo valor considerado na publicação de Nascimento et al. (2021), bem como a possibilidade de desencadear efeitos adversos locais e sistêmicos, incluindo inchaço e dor no local da injeção.

4.2 Local do estudo e coleta de dados

O estudo foi realizado em três regiões do Estado do Rio de Janeiro: a Região Metropolitana, incluindo os municípios do Rio de Janeiro (capital deste Estado) e Niterói; a Região da Baixada Litorânea (municípios de Rio das Ostras, Barra de São João e Silva Jardim) e a Região Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes e Macaé). Estas regiões foram selecionadas por critério como conveniência/viabilidade para realização do estudo, bem como na relevância socioeconômica desta para este Estado. Para cada uma dessas regiões foram aplicados 200 questionários, totalizando 600 respondentes. Considerando um nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%, foi estimado um número mínimo de 600 respondentes. O cálculo do tamanho amostral considerou um cenário em que 50% dos entrevistados estariam dispostos a pagar o valor de R$200,00 para serem vacinados, seguindo a premissa adotada nesta abordagem metodológica, que também foi utilizada em outros estudos publicados nesta abordagem (Haab & McConnell, 2003; Godói et al., 2017; Muniz Junior et al., 2019; Sarmento et al., 2019; Athie et al., 2021; Godói et al., 2021; Nascimento et al., 2021; Costa et al., 2022; Torres et al., 2024).

A coleta de dados foi realizada entre Agosto e Novembro de 2023. Antes da aplicação do questionário, todos os entrevistadores foram treinados pela professora responsável (IPDG) do estudo para garantir que todos os procedimentos recomendados para a condução desta técnica fossem seguidos (Godói et al., 2017; Sarmento et al., 2019; Muniz Junior et al., 2019; Godói et al., 2021; Nascimento et al., 2021). Os entrevistadores foram capacitados e orientados para sanar quaisquer dúvidas ou dificuldades que os participantes pudessem ter durante o processo de preenchimento da entrevista/questionário. Vale ressaltar que foi fornecido uma figura, para ilustrar o que seria a interpretação da informação referente à eficácia de 70% da vacina hipotética e, com isso, viabilizar esta compreensão.

4.3 Critérios de seleção e inclusão

A seleção dos participantes da pesquisa foi realizada por meio de amostragem de conveniência, convidando indivíduos que estivessem presentes em áreas de grande circulação, incluindo praças, shoppings, hospitais, universidades, feiras livres e praias. O número de entrevistados em cada cidade foi determinado com base no tamanho populacional relativo de cada município dentro de sua respectiva região.

Os critérios de exclusão incluíram indivíduos menores de 18 anos (maioridade civil no Brasil), bem como aqueles que tinham HIV positivos, seguindo as recomendações metodológicas desta técnica (Haab & McConnell, 2003; Godoi et al., 2017).

Além disso, os indivíduos que não aceitavam a vacina hipotética, mesmo com a opção de vacinação gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não foram incluídos na análise de Disposição a Pagar. Adicionalmente, foram excluídos aqueles cujo valor de DAP excedia o dobro da renda familiar mensal informada. Todos os critérios apresentados seguem premissas e recomendações desta abordagem metodológica (Godói et al., 2017; Muniz Junior et al., 2019; Sarmento et al., 2019; Athie et al., 2021; Godói et al., 2021; Nascimento et al., 2021; Costa et al., 2022).

4.4 Análise de dados

O valor da DAP da vacina anti-HIV foi avaliada com base na mediana declarada pelos participantes que se dispuseram a pagar qualquer valor igual ou superior a zero. O uso frequente da mediana na análise da DAP visa reduzir o impacto de valores extremamente baixos ou altos que possam surgir durante a coleta de dados (Haab & McConnell, 2003; Godói et al., 2017; Muniz Junior et al., 2019; Sarmento et al., 2019; Athie et al., 2021; Godói et al., 2021; Nascimento et al., 2021; Costa et al., 2022). Além disso, o valor mediano da DAP foi comparado entre as características dos participantes por meio do teste de Mann-Whitney para dois grupos, ou do teste de Kruskal-Wallis para três ou mais grupos, e o nível de significância foi de 5%. Adicionalmente, foram avaliadas correlações entre variáveis socioeconômicas e o valor máximo declarado para a vacina hipotética contra o HIV.

Considerando a renda *per capita*, os participantes foram estratificados em grupos com base no número de rendimentos salariais *per capita*, ou seja, número de salários mínimos. Os estratos de renda foram: “0-330”, “330-660”, “660-990”, “990-1320”, “1320-2460”,

“2460-3960”, “+3960”, que foram definidos com base em mediana e quartis, semelhante ao método aplicado em estudos anteriores (Athie et al., 2021; Nascimento et al., 2021). Os valores dos estratos representam valores de renda familiar entre R$ 0,00 e R$ 300,00 (US$ 65,48), R$ 330,01 (US$ 65,49) e R$ 660,00 (US$ 130,95), R$660,01 (US$ 130,96) e R$ 900,00 (US$ 196,43), R$ 900,01 (US$ 196,44) e R$ 1.320,00 (US$ 261,90), R$ 1.320,01 (US$ 261,91) e R$ 2.460,00 (US$ 488,10), R$ 2.460,01 (US$ 488,11) e R$ 3.960,00 (US$ 785,71), > R$ 3.960,00 (> US$ 785,71), respectivamente.

Quanto à escolaridade, os participantes foram estratificados em: “ensino fundamental incompleto”, “ensino fundamental completo”, “ensino médio completo” e “ensino superior completo ou pós-graduação”, novamente seguindo a abordagem de outros estudos analisados (Athie et al., 2021; Nascimento et al., 2021). Além disso, avaliou-se a DAP de indivíduos com e sem plano de saúde para verificar se esse aspecto poderia estar associado a uma influência no valor máximo que pagariam por esta vacina hipotética (Gustafsson-Wright et al., 2009).

A média da DAP, medida em escala de logaritmo natural, foi comparada entre os grupos por meio do teste ANOVA. Posteriormente, foi construído um modelo inicial de regressão linear multivariada, incorporando variáveis que apresentaram significância na análise univariada. Vale ressaltar que apenas as variáveis com valor-p < 0,05 foram retidas no modelo final. A análise de regressão foi realizada para explorar se o valor máximo que os participantes estavam dispostos a pagar pela vacina (variável dependente) foi influenciado ou correlacionado com características como sexo, idade e renda (variáveis independentes).

Todas as análises foram realizadas no Microsoft Excel 2010 e no software R 4.3.0, e foi utilizada a taxa de conversão fornecida pelo Banco Central do Brasil (2023: US$1.00 = R$5,04) (Banco Central, 2023).

4.5 Aspectos Éticos

Todas as entrevistas foram realizadas após leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Pará (COEP) sob o CAAE 12943619.5.0000.8607.

5. RESULTADOS

5.1. Características da População

Foram realizadas 600 entrevistas, e os participantes tinham faixa etária de 18 a 90 anos, com média de idade de 34 anos. Ademais, 28% dos participantes tinham entre 25 e 45 anos, e 17,7% tinham mais de 50 anos. O público feminino representou 53,5% dos entrevistados, 58,2% estavam empregados no momento da pesquisa, e 30,6% tinham ensino superior completo ou pós-graduação. Além disso, 60% relataram renda familiar *per capita* inferior a cinco salários mínimos, e 77,2% expressaram aceitabilidade para esta hipotética vacina contra o HIV, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Características dos entrevistados (n = 600)

Variável	n	(%)**
Idade em anos [média (SD)]	34 (±15.6)	5.7%
Mulheres	321	53.5%
Tem filho	218	36.3%
Nível de escolaridade		
Nunca estudou	0	0%
Ensino fundamental completo	38	6.3%
Ensino médio completo	369	61.5%
Ensino superior completo ou mais	184	30.6%
Situação de emprego		
Trabalhando no momento	349	58.2%
Aposentado	39	6.5%
Autônomo	88	14.7%
Tem plano de saúde privado	339	65.5%
Renda familiar (número de salários mínimos) *		
<1	58	9.7%
1-2	112	18.7%
2-3	68	11.3%
3-5	122	20.3%
5-10	98	16.3%
10-20	49	8.2%
>20	10	1.7%

*Notas: * 9,2% dos entrevistados se recusaram a responder sobre a renda familiar. ** O valor da diferença no atingimento de 100% em todas as questões se deve a respostas como "não sei" e "não quero responder".*

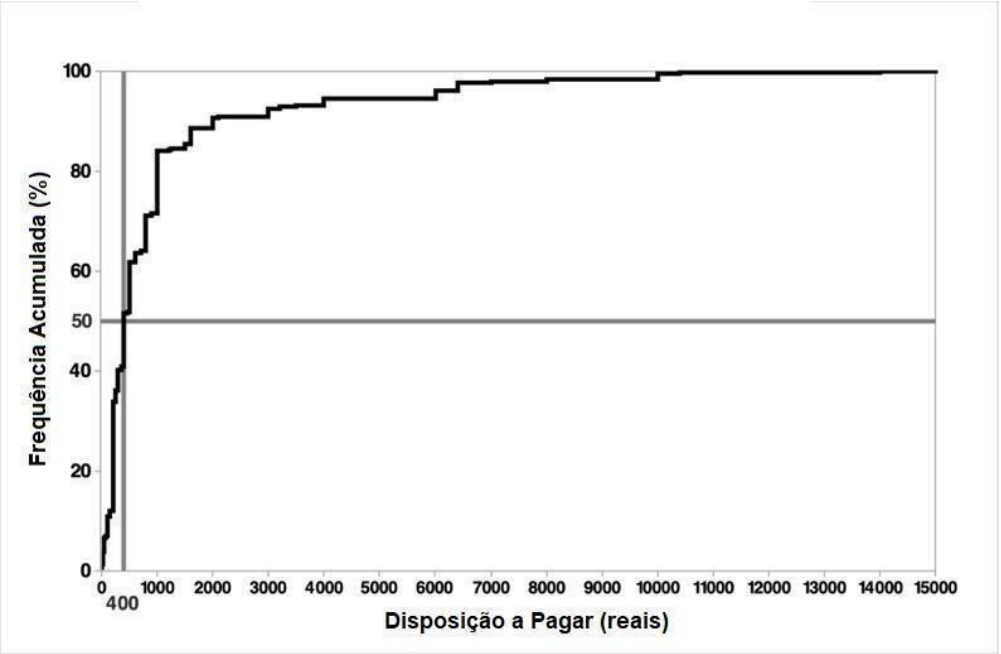
5.2. DAP para uma hipotética vacina contra o HIV

Dos 600 entrevistados, 87 afirmaram que não aceitariam ser vacinados nem mesmo de graça; consequentemente, foram excluídos da análise da DAP. Ademais, dos 463 entrevistados que indicaram que seriam vacinados, 11 não foram elegíveis para análise pois o valor máximo de DAP relatado era superior ao dobro da renda familiar. Como resultado, 452 participantes foram elegíveis para a análise da DAP.

Pela técnica de escolha discreta, observou-se que 16,4% dos 452 participantes tinham DAP de R$200,00 (US$39,68) para dose única da vacina hipotética. Adicionalmente, o valor médio obtido na análise foi de R$1.047,60 (US$207,86), e os valores mínimo e máximo de DAP declarados foram de R$0,00 e R$15.000,00 (US$2.976,19), respectivamente. O valor mediano para uma dose única da hipotética vacina contra o HIV foi de R$400,00 (US$ 79,37), o que significa que, aproximadamente, 50% dos indivíduos expressaram DAP máxima igual ou inferior a R$400,00 (US$ 79,37) (Figura 1).

Com base nas análises realizadas, observou-se significância estatística (p-valor < 0,05) para as variáveis renda familiar *per capita*, escolaridade, sexo e plano de saúde aplicado ao valor da DAP (Tabela 2). Entretanto, para as variáveis “situação profissional atual” e “ter filhos”, não houve diferença estatisticamente significativa (p > 0,05) no modelo final de regressão linear multivariada. A comparação da DAP entre participantes do sexo masculino e feminino mostrou uma pequena diferença, com mediana de R$500,00 (US$99,21) para homens e R$ 400,00 (US$79,37) para mulheres (Tabela 2).

Figura 1: Porcentagem acumulada de DAP para uma vacina hipotética contra o HIV de acordo com os valores máximos reportados.



Os estratos de renda ("0-330", "330-660", "660-990", "990-1320", "1320-2460", "2460-3960", "+3960") estão relacionados aos valores da renda familiar *per capita* conforme a Figura 2. Vale ressaltar que os valores medianos de cada faixa de renda *per capita* apresentada anteriormente, associada à DAP para a hipotética vacina contra o HIV, foi respectivamente de R$ 200,00, R$ 400,00, R$ 400,00, R$ 400,00, R$ 600,00, R$ 900,00 e R$ 950,00. Nesse contexto, para as faixas de renda entre R$330-660, R$660-990 e R$990-1320, obteve-se o mesmo valor de DAP de R$400,00 (Figura 2).

Em relação à variável escolaridade, houve tendência de maiores níveis de escolaridade estarem associados a um maior valor de DAP para a vacina hipotética contra o HIV. O valor da DAP foi de R$1.000,00 (US$198,41) para indivíduos com ensino superior e pós-graduação, comparado a R$200,00 (US$39,68) para indivíduos com ensino fundamental incompleto ou completo. Além disso, o mesmo valor de DAP de R$400,00 (US$79,37) foi observado para os entrevistados que tinham ensino fundamental completo eensino médio completo, conforme mostrado na Figura 3.

Tabela 2: Análise univariada associada para cada variável

	DAP (BRL)			
Variável	Mediana	Q1	Q3	p-Valor* (%)
Renda familiar *per capita* (mw/BRL)				<0.001
0-330	200	200	400	
330-660	400	200	800	
660-990	400	200	800	
990-1320	400	200	800	
1320-2640	600	210	1600	
3640-3960	900	400	1125	
3960+	950	500	3150	
Nível de escolaridade				<0.001
Nunca estudou	200	175	425	
Ensino fundamental completo	400	200	950	
Ensino médio completo	400	200	1000	
Ensino superior completo ou mais	1000	500	2000	
Gênero				0.018
Homem	500	200	1000	
Mulher	400	200	1000	
Seguro de saúde				<0.001
Não	300	6	800	
Sim	500	0	1000	
Trabalha no momento				0.158
Não	400	6	800	
Sim	400	0	1000	
Tem filho				0.129
Não	400,0	6	1000	
Sim	500,0	0	1000	

**Teste de Mann-Whitney/Kruskal-Walli; BRL: Real Brasileiro; Q1: primeiro quartil; Q3: terceiro quartil*

Figura 2: Boxplot indicando a disposição a pagar por uma vacina hipotética contra o HIV de acordo com a faixa de renda familiar *per capita*.

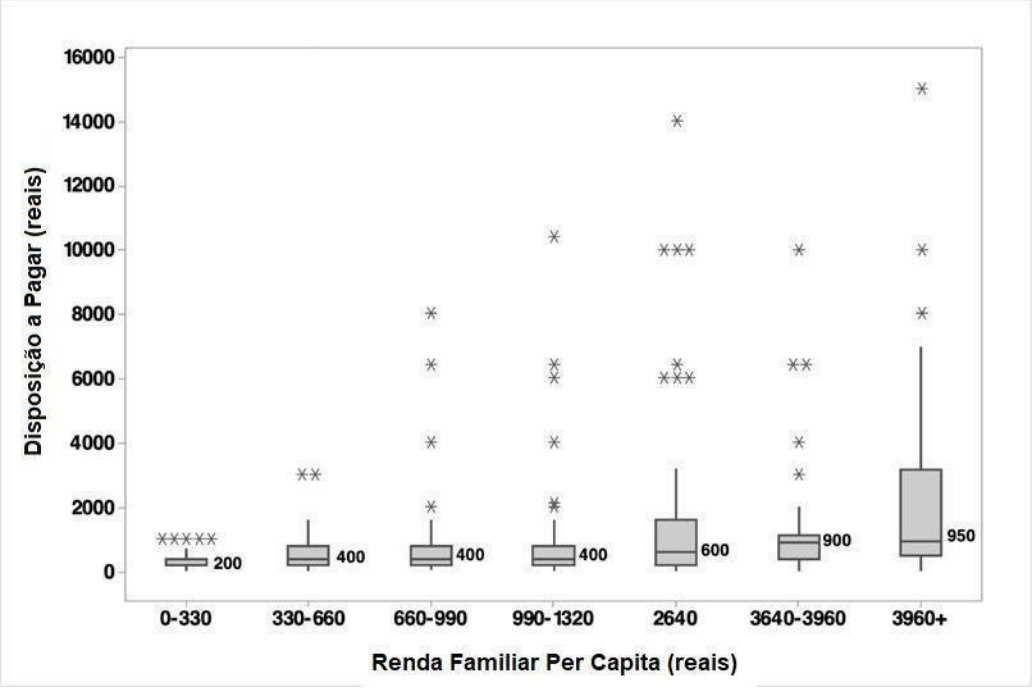
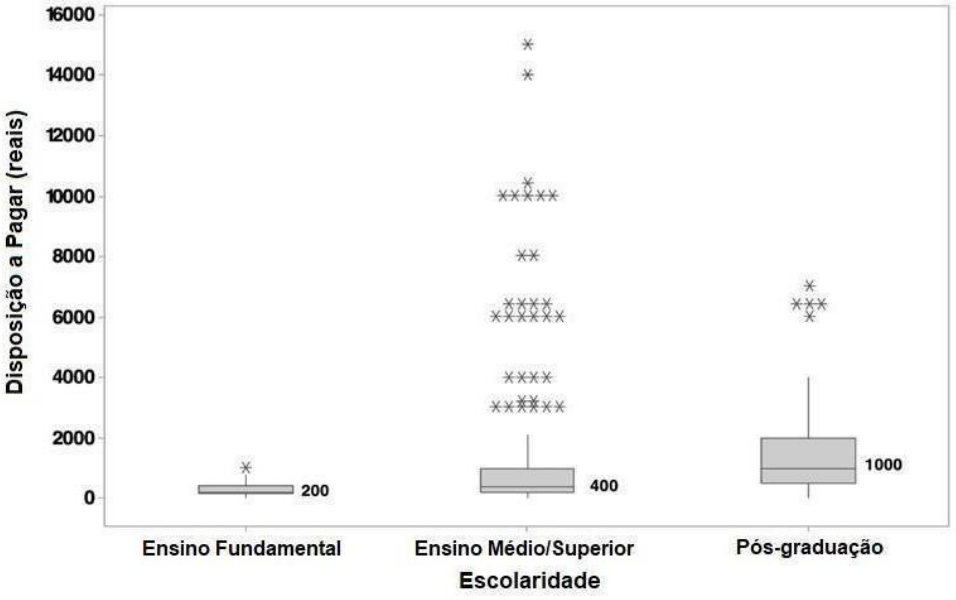


Figura 3: Boxplot indicando a disposição a pagar por uma vacina hipotética contra o HIV de acordo com o nível de escolaridade



O presente estudo não encontrou associação significativa entre a disposição de pagar pela vacina hipotética anti-HIV e as variáveis “atualmente empregado” (p-valor = 0,158) e “ter filhos” (p-valor = 0,129).

6. DISCUSSÃO

Este é o primeiro estudo realizado no Estado do Rio de Janeiro que avaliou a DAPpara uma vacina hipotética, tendo como base na DAP dos consumidores da região Norte do Brasil (Estado do Pará), empregando a mesma metodologia. No entanto, descobrimos quea DAP declarada pelos consumidores no Estado do Rio de Janeiro foi de R$400,00 (US$79.37), significativamente maior quando comparada com o estudo anterior de Nascimento e colaboradores (2021) no Pará, onde os participantes declararam um valor de DAP de R$200,00 (US$ 47.50). Verificamos algumas semelhanças entre o perfil da nossa amostra com a da população do Rio de Janeiro, que apresenta 52,8% de mulheres e 47,2% de homens (IBGE, 2022b; G1, 2023b), próximo ao observado ao público entrevistado de 53,5% de mulheres e 46,5% de homens. Além disso, a média de idade da população deste Estado era de 37 anos, semelhante à nossa população com idade média de 34 anos (IBGE, 2022b). Adicionalmente, segundo o Ministério da Saúde, entre 2007 e 2023, foram registrados 489.594 novos casos no Brasil, casos associados, principalmente, no público masculino (70,5%). Além disso, 42,4% do total de indivíduos foram identificados como pardos, e 19% com idade entre 25 anos. e 29 anos (Brasil, 2023b).

Ressalta-se que Estado do Pará é o segundo maior Estado em extensão territorial do país, com população estimada em cerca de 8 milhões de habitantes (2022), Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,69 (2021) e renda *per capita* mensal de R$1.282,00 (2023) (IBGE, 2024b). Isso se compara a uma população de, aproximadamente, 16 milhões de habitantes, um IDH de 0,762 e uma renda *per capita* mensal de R$2.367,00 (2023) no Estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2024c). Ademais, o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio de Janeiro em 2021 foi de R$ 949.301.000,00, enquanto o PIB do Pará foi de R$ 262.905.000,00 (IBGE, 2022a), sendo o Estado do Rio de Janeiro o segundo maior PIB do Brasil e o Pará ocupando o décimo lugar. Adicionalmente, nos participantes com plano de saúde privado em nosso estudo houve maior DAP em comparação com aqueles sem plano privado ($p < 0,001$). Acreditamos que isso seja importante uma vez que, aproximadamente, 60% dos participantes tinham

plano de saúde privado em nosso estudo, em comparação com mais de 30% no Estado, e 26,3% nacionalmente, e apenas 10% a 20% no Pará (Sestelo, Tavares & Silva, 2022; Brasil, 2024c). Indivíduos com planos de saúde privados geralmente apresentam maior renda familiar *per capita* e/ou emprego forma que pode influenciar seu poder de compra e a DAP para um produto hipotético ou real (Godói et al., 2017; Godói et al., 2021). Estas descobertas endossam publicações anteriores de que questões-chave como epidemiologia, renda e níveis educacionais podem influenciarsensivelmente a DAP para vacinas hipotéticas ou reais (Haab & McConnell, 2003; Godóiet al., 2017).

Dessa forma, considerando as informações socioeconômicas apresentadas anteriormente para os Estados do Pará e Rio de Janeiro, juntamente com a tendência comumente observada entre a renda *per capita* familiar e o valor da DAP, pode-se compreender melhor o maior valor da DAP nos consumidores cariocas (R$400,00), em comparação com o estudo realizado no Pará (R$200,00) (Haab & McConnell, 2003; Godóiet al., 2021; Nascimento et al., 2021). De forma encorajadora, um padrão notável foi observado para o impacto da educação na DAP, com participantes que tinham níveis educacionais mais elevados mostrando uma maior probabilidade de pagar mais pelo hipotética vacina, em comparação com aqueles com níveis de escolaridade mais baixo ($p < 0,001$) espelhando com outros estudos realizados no país (Godói et al., 2017; Muniz Junioret al., 2019; Sarmento et al., 2019; Athie et al., 2021; Nascimento et al., 2021).

Curiosamente, 77,2% dos 600 participantes do nosso estudo expressaram a aceitabilidade de uma hipotética vacina contra o HIV com as características escolhidas. No entanto, este valor foi inferior ao de outros estudos comparativos que aplicaram o mesmo tema, como a aceitabilidade entre as populações encarceradas nos Estados Unidos foi de 94% (Lally et al., 2006), 93% de aceitabilidade aplicada em Uganda a um público de adultos nos seus melhores anos de rendimento e de procriação (Bishai et al., 2004), e no Estado do Pará com 94% (Nascimento et al., 2021). O resultado obtido de 77,2% de aceitabilidade pode estar associado à hesitação vacinal no país, reflexo do aumento da disseminação de notícias falsas contra as vacinas e do movimento antivacina, observado nos últimos anos no Brasil (Fernandez, Matta & Paiva, 2022; Sousa et al., 2022). Entretanto, a aceitabilidade foi superior a um estudo realizado no Canadá com público alvoconsumidores de drogas (Fleming et al., 2020), que embora não fornecesse dados numéricos sobre a aceitação de uma vacina hipotética contra o HIV, os autores descobriramque a vontade de ser vacinado era baixa. Paralelamente, a hesitação

da população no nosso estudo também pode ser explicada pelas dúvidas crescentes sobre as vacinas nos últimos anos, particularmente sobre a COVID-19, após considerável desinformação nos meios de comunicação social (Bernadeau-Serra et al., 2021; Campelo et al., 2021; Fernandez, Matta & Paiva, 2022). Isso porque, desde o início da pandemia, houve um aumento de notícias falsas e desinformação divulgadas por diversos canais informativos, o que impacta a adesão às vacinas entre a população brasileira (Campelo et al., 2021; Galhardi et al., 2022; Souza et al., 2022). Dito isto, há esforços crescentes por parte dos investigadores e do Ministério da Saúde para combater a desinformação sobre vacinas no país (Fernadez, Matta & Paiva, 2022; Galhardi et al., 2022). Isto ratifica a importância em esclarecer continuamente os reais benefícios da imunização para a saúde individual e da população através das redes sociais e de outros canais importantes (Godói et al., 2021).

Adicionalmente, aos demais indivíduos que foram excluídos da análise de DAP (22,8%) por uma vacina hipotética contra o vírus do HIV, foram realizadas perguntas para o entendimento do motivo da resposta. Esse total foi dividido entre pessoas que não pagariam pela vacina, mas aceitariam tomar de graça (30,7%), indivíduos que não tomariam a vacina nem mesmo de graça (32,8%), e aqueles que não sabiam responder e/ou não quiseram responder (36,5%). Em relação a aqueles que nem mesmo de graça tomariam o imunizante, 35,5% justificaram pelo medo em relação à segurança das vacinas; 26,7% consideravam 70% de eficácia baixa; 31,1% relataram outros motivos, como a não utilização de vacinas por questões religiosas.

Embora uma futura vacina contra o HIV seja uma estratégia importante para prevenir contra este vírus, e pode contribuir para reduzir o número de casos e mortes, conforme enfatizado por organizações de saúde nacionais e internacionais aplicadas aos benefícios da vacinação (Bernadeau-Serra et al., 2021; Campelo et al., 2021; WHO, 2024), as campanhas de prevenção e cuidados devem ser sempre incentivadas e mantidas, pois as vacinas nãosão 100% eficazes e indivíduos em todo o mundo recusam ou resistem à vacinação.

Estamos cientes de uma série de limitações do estudo. Primeiramente, escolhemos uma vacina hipotética com 70% de eficácia, que poderia variar após os resultados de estudos e ensaios para uma futura vacina licenciada. Em segundo lugar, incluímos apenas três regiões do Estado do Rio de Janeiro pelas razões expostas. Reforça que a amostra apresentou algumas características, conforme apresentadas na Tabela 1,

semelhantes quando comparadas com a população brasileira, incluindo o maior percentual de mulheres (51,6%), um baixo percentual de indivíduos que nunca estudaram (8,5%) e o percentual de indivíduos com pelo menos 11 anos de escolaridade (41,8%) (IBGE, 2014). Contudo, a amostra aleatória utilizada pode não ser totalmente generalizável para a população do Brasil como um todo. Além disso, poderia haver um possível viés de seleção associado ao recrutamento e inclusão dos participantes. Entretanto, assemelha-se à outros estudos sobre DAP realizados no Brasil (Godói et al., 2017; Muniz Júnior et al., 2018; Sarmento et al., 2019; Godói et al., 2021; Athie et al., 2021; Nascimento et al., 2021). Ressaltamos que, infelizmente, não avaliamos a correlação de disposição a pagar pela vacina hipotética contra o HIV e a cor da pele declarada pelo participante Contudo, em outras pesquisas nesta temática deste grupo de pesquisa, esperamos incluir este tipo de análise. Apesar dessas limitações, acredita-se que o presente estudo forneça informações que poderão ser benéficas para a indústria farmacêutica e para o governo, dados os resultados obtidos para um dos principais Estados do país, que ainda enfrenta inúmeros desafios e consequências associadas à morbidade e mortalidade desta infecção. Este estudo poderá contribuir para futuras discussões sobre preços de vacinas.

7. CONCLUSÃO

O estudo apresentou um percentual de 77,2% de aceitabilidade entre os entrevistados em relação a uma vacina hipotética contra o HIV com 70% de eficácia e valor de DAP de R$400,00 (US$79,37). Considerando o elevado número de mortes e casos associados a esta infecção em todo o mundo, é essencial continuar os esforços e estratégias que visam encontrar uma vacina segura e eficaz contra este retrovírus.

Além disso, este estudo demonstrou alguns desafios para a Gestão da Saúde aplicadosà relevância de promover e incentivar a vacinação no país, especialmente, em alguns Estados onde se observou uma menor aceitabilidade de uma hipotética vacina contra oHIV como o Estado do Rio de Janeiro (72%) quando comparado com o Estado do Pará (93%) (Nascimento et. al., 2021), dados obtidos neste estudo e outro desenvolvido por este mesmo grupo de pesquisa.

Espera-se que no futuro tenhamos não apenas uma, mas várias vacinas contra o HIV que possam contribuir para a redução da morbilidade e mortalidade associadas a esta

patologia. Durante as discussões envolvendo fabricantes e órgãos reguladores oficiais sobre a precificação de futuros produtos imunobiológicos, espera-se que as especificidades (por exemplo, geográficas, logísticas) e limitações (por exemplo, fatores socioeconômicos, hesitação em vacinar, restrições orçamentárias) experimentadas nos países em desenvolvimento, como o Brasil, sejam considerados.

Por fim, o presente estudo também possui potencial em contribuir para futuras pesquisas nestas áreas, enfatizando a importância de incluir diversos cenários geográficos, económicos e sociais, uma vez que estes serão os potenciais mercados consumidores para uma futura vacina contra o HIV.

8. REFERÊNCIAS

ADMINISTRADOR. HIV: sintomas, transmissão e prevenção. Disponível em: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/sintomas-transmissao-e-prevencao-nat-hiv. Acesso em: 9 ago. 2023.

ANDERSON, J.; FENTON, K. HIV related stigma: a dangerous roadblock. The BMJ, p. o2989–o2989, 12 dez. 2022

Anvisa aprova primeiro medicamento injetável contra o HIV. G1. 2023a. Disponível em: https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/06/10/anvisa-aprova-primeiro-medicamento-injetavel-contra-o-hiv.ghtml. Acesso em: 16 ago. 2023.

Araújo FH, & Fernandes LH. Lighting the populational impact of COVID-19 vaccines in Brazil. Fractals. 2022. 30(3)2250066. Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0218348X22500669. Acesso em: 3 out. 2023.

A Study of Heterologous Vaccine Regimen of Adenovirus Serotype 26 Mosaic4 Human Immunodeficiency Virus (Ad26.Mos4.HIV), Adjuvanted Clade C gp140 and Mosaic gp140 to Prevent HIV-1 Infection Among Cis-gender Men and Transgender Individualsm Who Have Sex With Cis-gender Men and/or Transgender Individuals (MOSAICO). Disponível em:https://clinicaltrials.gov/study/NCT03964415?a=52. Acesso em: 14 out. 2023.

ATHIE et al. Consumer willingness to pay for a hypothetical Chagas disease vaccine in Brazil: a cross-sectional study and the implications. Journal of Comparative Effectiveness Research, v. 10, n. 8, p. 659–672, 1 jun. 2021.

Banco Central do Brasil. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes. Acesso em: 14 dez. 2023.

BERNADEAU-SERRA, L. et al. The COVID-19 Vaccination Strategy in Brazil – A Case Study. Epidemiologia (Basel), v. 2, n. 3, p. 338-359, 12 ago. 2021.

Bishai, D., Pariyo, G., Ainsworth, M., & Hill, K. (2004). Determinants of personal demandfor an AIDS vaccine in Uganda: contigent valuation survey. Bulletin of the World Health Organization, 82(9), 652-660. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/269236/PMC2622986.pdf?sequence=1&isAl lowed=y

Brasil | Cidades e Estados | IBGE. (2024a). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html. Acesso em: 29 fev. 2024.

Brasil. Ministério da Saúde. (2020). RESOLUÇÃO CMED Nº 2, DE 5 DE MARÇO DE 2004 — Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/air/arquivos/5517json-file-

1/view. Acesso em: 18 ago. 2023.

Brasil. Ministério da Saúde. (2023a). Aids/HIV. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aids-hiv. Acesso em: 28 nov. 2023.

Brasil. Ministério da Saúde. (2023b). Boletim Epidemiológico - HIV e Aids 2023 — Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2023/hiv-aids/boletim-epidemiologico-hiv-e-aids-2023.pdf/view. Acesso em: 9 fev. 2024.

Brasil. Ministério da Saúde. (2023c). Anvisa aprova novo medicamento para prevenção do HIV. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023/anvisa-aprovou-um-novo-medicamento-para-a-profilaxia-do-hiv. Acesso em: 10 out. 2023.

Brasil. Ministério da Saúde. (2023d). Conheça a Conitec. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/a-comissao/conheca-a-conitec. Acesso em: 18 ago. 2023.

Brasil. Ministério da Saúde. (2023e). Nova estratégia de vacinação contra a Covid-19 começa a valer em 1º de janeiro. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/nova-estrategia-de-vacinaca o-contra-covid-19-comeca-a-valer-em-1o-de- janeiro. Acesso em: 10 jan. 2024.

Brasil. Ministério da Saúde. (2023f). Calendário Nacional de Vacinação. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao. Acesso em: 31 out. 2023.

Brasil. Ministério da Saúde. (2024a). Programa Nacional de Imunizações - Vacinação. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programa-nacional-d e-imunizacoes-vacinacao. Acesso em: 1 abr. 2024.

Brasil. Ministério da Saúde. (2024b). Calendário de Vacinação. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario. Acesso em: 1 abr. 2024.

Brasil. Ministério da Saúde. (2024c). Dados Gerais. Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-gerais. Acesso em: 3 fev. 2024.

Caires de Souza, A.L. et al. Insulin Glargine in a Brazilian State: Should the Government Disinvest? An Assessment Based on a Systematic Review. Applied health economics and health policy, v. 12, n. 1, p. 19–32, 3 jan. 2014.

CAMPELO, D. et al. Low COVID-19 vaccine hesitancy in Brazil. Vaccine, v. 39, n. 42, p. 6262–6268, 1 out. 2021.

COMITÊ INTERNACIONAL DE TAXONOMIA VIRAL (ICTV). Família: Retroviridae.Versão do Capítulo: 9º Relatório do ICTV; 2009. Taxonomia Liberação de propriedades do Virion. Disponível em: https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/reverse-transcribe-dna-and-rna-viruses2 011/w/rt_viruses/161/retroviridae

COSTA, M. J. L. et al. Willingness to pay for a hypothetical malaria vaccine in Brazil: a cross-sectional study and the implications. Journal of Comparative Effectiveness Research. v. 11, p. 1-12, 2022.

ESTATÍSTICAS MUNDIAIS SOBRE O HIV 2021. [sl: sn]. Disponível em: https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2021/06/2020_11_19_UNAIDS_FactSheet_PORT_Revisada-Final.pdf.

Estatísticas - UNAIDS Brasil 2022. Disponível em: https://unaids.org.br/estatisticas/. Acesso em: 9 ago. 2023.

ESTHER, A. et al. EVOLUTION OF PATIENTS WITH AIDS AFTER cART: CLINICAL AND LABORATORY EVOLUTION OF PATIENTS WITH AIDS AFTER 48 WEEKS OF ANTIRETROVIRAL TREATMENT. Revista Do Instituto De Medicina Tropical De SaoPaulo, v. 55, n. 4, p. 267–273, 1 jul. 2013.

FERNANDEZ, M.; MATTA, G.; PAIVA, E. COVID-19, vaccine hesitancy and child vaccination: Challenges from Brazil. The Lancet Regional Health - Americas, v. 8, p. 100246–100246, 1 abr. 2022.

FÉVRIER, M.; DORGHAM, K.; REBOLLO, A. CD4+ T Cell Depletion in Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection: Role of Apoptosis. Viruses, v. 3, n. 5, p. 586–612, 12 mai. 2011.

FLEMING, T. et al. Acceptability of a hypothetical preventative HIV vaccine among people who use drugs in Vancouver, Canada. BMC Public Health, v. 20, n. 1, 9 jul. 2020.

GALHARDI, C.P. et al. Fake News and vaccine hesitancy in the COVID-19 pandemic in Brazil. Ciência & Saúde Coletiva (Impresso), v. 27, n. 5, p. 1849–1858, 1 maio 2022.

GODÓI, I. P. D. et al. Acceptability and willingness to pay for a hypothetical vaccine against SARS CoV-2 by the Brazilian consumer: a cross-sectional study and the implications. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, v. 22, n. 1, p. 119–129, 14 jun. 2021.

GODÓI, I. P.. et al. Consumer Willingness to Pay for Dengue Vaccine (CYD-TDV, Dengvaxia®) in Brazil; Implications for Future Pricing Considerations. Frontiers in Pharmacology, v. 8, 2 fev. 2017.

GREENWOOD, G. L. et al. HIV-Related Stigma Research as a Priority at the National Institutes of Health. AIDS and Behavior, v. 26, n. S1, p. 5–26, 22 abr. 2021.

Gürtler, L. et al. Human Immunodeficiency Virus (HIV). Transfusion medicine and hemotherapy, v. 43, n. 3, p. 203–222, 1 jan. 2016.

GUSTAFSSON-WRIGHT, E.; ASFAW, A.; JACQUES. Willingness to pay for health insurance: An analysis of the potential market for new low-cost health insurance products in Namibia. Social Science & Medicine, v. 69, n. 9, p. 1351–1359, 1 nov. 2009.

Haab, T. C., & McConnell, K. E. (2003). Valuing environmental and natural resources: the econometrics of non-market valuation. Edward Elgar Pub.

IBGE. (2014). Síntese de Indicadores Sociais:Uma Análise das condições de vida da População Brasileira. Brasilia, Brasil 2014 . Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91983.pdf. Acesso em: 30 mar 2024.

Inflação | IBGE. (2023). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php. Acesso em: 14 dez. 2023.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE. (2022b). Panorama do Censo 2022. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/. Acesso em: 5 mar. 2024.

LALLY, M. et al. Willingness to receive an HIV vaccine among incarcerated persons. Preventive Medicine, v. 43, n. 5, p. 402–405, 1 nov. 2006.

LAURINDO, L.; TEIXEIRA, PR VOLUME II A sociedade civil se organiza pela luta contraa aids. [sl: sn]. Disponível em: https://prceu.usp.br/wp-content/uploads/2020/05/HISTORIAS_DA_AIDS_NO_BRASIL.pdf

Mais de um milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil, estima Ministério da Saúde. CNN Brasil. (2023a). Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mais-de-um-milhao-de-pessoas-vivem-com-hiv-no-brasil-estima-ministerio-da-saude/. Acesso em: 10 ago. 2023.

MELO, B. et al. Epidemiologia e aspectos imunopatológicos do vírus da imunodeficiência humana (HIV): revisão de literatura. Revista Ceuma Perspectivas, 31 jul. 2018.

Muniz Junior, R. L., Godoi, I. P., Reis, E. A., Garcia, M. M., Guerra-Junior, A. A.,Godman, B., & Ruas, C. M. (2019). Consumer willingness to pay for a hypothetical Zika vaccine in Brazil and the implications. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14737167.2019.1552136. Acesso em: 18 ago. 2023.

NASCIMENTO, G. C. et al. Acceptability and consumer willingness to pay for a hypothetical HIV vaccine in Northern Brazil: a cross-sectional study and the implications - Strathprints. Strath.ac.uk, 3 abr. 2021.

NYAMWEYA, S. et al, Comparing HIV-1 and HIV-2 infection: Lesson for viral immunopathogenesis. Reviews in Medical Virology, v. 23, n. 4, p. 221-240, 26 fev. 2013.

Pará | Cidades e Estados | IBGE. (2024b). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa.html. Acesso em: 4 mar. 2024.

PAREDES, R.; BONAVENTURA CLOTET. Clinical management of HIV-1 resistance. Antiviral Research, v. 85, n. 1, p. 245–265, 1 jan. 2010.

Phase 3 Mosaic-Based Investigational HIV Vaccine Study Discontinued Following Disappointing Results of Planned Data Review. Disponível em: https://www.hvtn.org/news/news-releases/2023/01/phase-3-mosaic-based-investigational-hiv-vaccine-study-discontinued-following-disappointing-results-planned-data-review.html. Acesso em: 5 mar. 2024.

Produto Interno Bruto - PIB | IBGE. (2022a). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 1 fev. 2024.

REEVES, I. et al. British HIV Association guidelines for the management of HIV-2 2021. HIV Medicine, v. 22, n. S4, p. 1–29, dez. 2021.

RJ é o estado com maior proporção de mulheres do país, aponta Censo. G1. (2023b). Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/10/27/rj-eo-estado-com-a-maior-proporcao-de-mulheres-do-pais-aponta- censura.ghtml. Acesso em: 5 mar. 2024.

RETROSPECTIVA 2022: Brasil registra queda de infecções por HIV, mas casos aumentam entre jovens – Agência AIDS. Disponível em: https://agenciaaids.com.br/noticia/retrospectiva-2022-brasil-registra-queda-de-infeccoes-por-hiv-mas-casos-aumentam-entre-jovens/. Acesso em: 10 ago. 2023.

Rio de Janeiro | Cidades e Estados | IBGE. (2024c). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj.html. Acesso em: 4 mar. 2024.

Sarmento, T., Godoi, I. P., Reis, E. A., Godman, B., & Ruas, C. M. (2019). Consumer willingness to pay for a hypothetical chikungunya vaccine in Brazil and the implications. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14737167.2020.1703181. Acesso em: 18 ago. 2023.

Secretaria Estadual de Saúde - Rio de Janeiro (SESRJ). Painel de indicadores de HIV. Disponível em: https://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnetbd/dash/dash_hiv.htm. Acesso em:29 fev 2024.

Senado Federal. A Aids chegou ao Brasil há 40 anos e trouxe terror, preconceito e desinformação. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/aids-chegou-ao-brasil-ha-40-anos-e-trouxe-terror-preconceito-e-desinformacao. Acesso em: 10 out. 2023.

SESTELO, JAF; TAVARES, LR; SILVA, MSMD Planos e seguros de saúde: a financeirização de empresas e grupos econômicos controladores do esquema comercial privativo de assistência no Brasil. Cadernos de Saúde Pública (Impresso), v. fornecimento 2, 1º de janeiro. 2022.

SHARP, P. M.; HAHN, B. H. Origins of HIV and the AIDS Pandemic. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, v. 1, n. 1, 1 set. 2011.

SILVA, MFB Manifestações clínicas e orofaciais de pacientes vivendo com HIV na era pós-HAART. 2 fora. 2018.

SOUSA, I. et al. Anti-vaccination movements in the world and in Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (Impresso), v. 55, 1 jan. 2022.

SUPERVIE et al. Heterosexual Risk of HIV Transmission per Sexual Act Under Combined Antiretroviral Therapy: Systematic Review and Bayesian Modeling. Clinical Infectious Diseases, v. 59, n. 1, p. 115–122, 9 abr. 2014.

TRICKEY, A. et al. Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013: a collaborative analysis of cohort studies. The Lancet HIV, v. 4, n. 8, p. e349–e356, 1 ago. 2017.

TÔRRES, L. et al. Acceptability and consumers' willingness to pay for comprehensive medication management services in Brazil. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/378074684_Acceptability_and_consumers%27_willingness_to_pay_for_comprehensive_medication_management_services_in_Brazil. Acesso em: 1 mar. 2024.

World Health Organization. WHO. (2023). HIV and AIDS. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids. Acesso em: 9 ago. 2023.

World Health Organization. WHO. (2024). Vaccines and immunization. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1. Acesso em: 4 mar. 2024.

9. APÊNDICE

instituto de ciências farmacêuticas
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Macaé

Formulário para coleta de dados clínicos e sociodemográficos de voluntários entrevistados para a avaliação da disposição a pagar pela vacina do HIV

CONHECIMENTO PRÉVIO SOBRE A AIDS

O(A) senhor(a) conhece a AIDS? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Não respondeu

O(A) senhor(a) conhece alguém que já teve AIDS? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Nãorespondeu

O(A) senhor(a) sabe quais são os sintomas da AIDS? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Nãorespondeu

O(A) senhor(a) sabe como a AIDS é transmitida? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Nãorespondeu

O(A) senhor(a) faz alguma coisa em casa para proteger da AIDS? O que? ( ) Sim ( ) Não ( ) Nãosabe ( ) Não respondeu

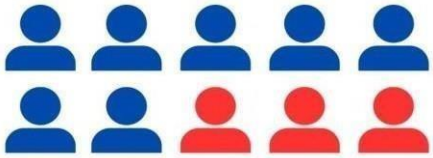
INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV)

Entrevistadores devem ler o seguinte conteúdo:

O vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é o agente causador da Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS). Ser portador do HIV não é a mesma coisa que ter AIDS, uma vez que há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. A AIDS se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico do corpo, com oorganismo mais vulnerável ao aparecimento de doenças oportunistas que vão de um simplesresfriado a infecções mais graves, como tuberculose ou câncer. O próprio tratamento dessasdoenças fica prejudicado com a presença do vírus HIV no organismo. Ele é capaz de atacar osistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças e é classificado como um retrovírus da subfamília dos *Lentiviridae*. Dentre as formas de contaminação destacamos: osexo sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sanguecontaminado, da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação. Após a infecção pelo HIV o sistema imunológico começa a ser atacado e a primeira fase, chamada de infecção aguda, caracteriza-se pela incubação do vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença, que se assemelha muito aos de uma gripe e pode durar de três aseis semanas. A próxima fase é marcada pela forte interação entre as células de defesa levandoa um enfraquecimento do organismo o suficiente para permitir novas doenças, período que podem durar muitos anos, chamado de assintomático. Ao longo dos anos muitos medicamentosforam desenvolvidos e os portadores do HIV tem o direito de receber pelo SUS todo o tratamentoe acompanhamento de profissionais de saúde para o sucesso da terapia. O organismo leva de 30 à 60 dias após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV. Os primeiros sintomas são muitoparecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida. Em 2017, a partir de dados do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidadeassociada a Aids foi de 4,8 para cada 100.000 habitantes no Brasil. A taxa de detecção no país,

ao longo dos anos, vem reduzindo podendo ser observado entre 2012 a 2017 que passou, respectivamente, de 21,7 casos por cada 100 mil habitantes para 18,3, representando uma quedade 15,7%.

Suponha que em um cenário hipotético seja disponibilizada para comercialização uma vacina para a prevenção da AIDS, dose única com eficácia de 70% e proteção para toda a vida, não necessitando de dose reforço. Suponha que 10 pessoas tomaram a vacina, e que outras pessoasnão a tomaram. A vacina da AIDS não é 100% efetiva, mas 70%. Dessa forma, das 10 pessoasque tomarama vacina da AIDS, 7 estão protegidas, e as outras 3 não estão protegidas, mesmo tendo tomado a vacina. Elas continuam em risco de pegar AIDS da mesma forma como antes de tomar a vacina ou como as pessoas que não tomaram.



Nós gostaríamos de saber o que o (a) senhor (a) faria se esta vacina hipotética estivesse disponível para a venda em um local conveniente como uma clínica, por exemplo. Essa vacina poderia ser dada aos indivíduos para prevenir AIDS no futuro. Ela não pode ser usada por alguém que esteja com doença de chagas no momento da vacinação. Mulheres grávidas não poderiam tomar a vacina. O esquema de vacinação compreende em uma única dose, que pode ser utilizada em crianças a partir de nove meses, tendo duração por toda a vida do indivíduo.

Agora eu vou te fazer algumas perguntas para ter certeza que as informações que eu te passei estão claras.

CONFERÊNCIA SOBRE A COMPREENSÃO DO CONTEXTO

Como que a AIDS é transmitida?

Como você pode prevenir AIDS?

Se você já teve AIDS, você pode ter novamente?

Qual a eficácia da vacina hipotética apresentada para a AIDS?

Parte 1

Suponha que fosse aprovada no Brasil uma vacina para ser comercializada para a prevençãoda AIDS. Você aceitaria pagar para ser vacinada para este produto?”

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Não respondeu

“Suponha que a vacina da AIDS custa 200,00 reais. Você pagaria por essa vacina” ( ) Sim ( )Não ( ) Não sabe ( ) Não respondeu

Você pagaria a vacina para seu(s) filho(s)?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Não respondeu

Se o indivíduo responde que não compraria a vacina pelo preço descrito:“O(A)

senhor(a) tomaria a vacina se ela fosse fornecida de graça?”
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Não respondeu

Se o indivíduo respondeu não:

"Por que o(a) senhor(a) não tomaria a vacina?"( )
Segurança
( ) Eficácia
( ) Não utiliza vacinas
Outro: _____

Parte 2

Se SIM, dobrar o valor até o indivíduo dizer não:

( ) 400,00
( ) 800,00
( ) 1600,00
( ) 3200,00
( ) 6400,00

Se NÃO, dividir o valor até o indivíduo dizer sim:
( ) 100,00
( ) 50,00
( ) 25,00
( ) 12,50
( ) 6,25

"O senhor respondeu que pagaria entre X_0 e X_1 reais para tomar a dose única da vacina daAids. Qual valor o senhor acha que é o máximo que o senhor pagaria para tomar essa vacina?"_____

PESQUISA DE OPINIÃO

Data de nascimento:_____/_____/_____ Sexo:_____

Cidade:_____Região/Núcleo: _____

Escolaridade: ( ) Nunca estudou ( ) Fundamental Completo ( ) Fundamental incompleto ( ) Médio incompleto ( ) Médio completo ( ) Superior incompleto ( ) Superior completo ( ) Pós-graduação incompleto ( ) Pós-graduação completo ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Não sabe ( ) Não quer responder

Renda total no domicílio:

( ) Até 1 salário mínimo (≤R$ 1320,00)

( ) 1-2 salários mínimos (R$ 1320,01 a R$ 2640,00)( ) 2-3 salários mínimos (R$ 2640,01 a R$ 3960,00)( ) 3-5 salários mínimos (R$ 3960,01 a R$ 6600,00)

( ) 5-10 salários mínimos (R$ 6600,01 a R$ 13.200,00)

( ) 10-20 salários mínimos (R$ 13.200,01 a R$ 26.400,00)( ) mais de 20 salários mínimos (≥R$ 26.400,01)

( ) Não sabe ( ) Não quer responder

Número de pessoas no domicílio:_____(quantas pessoas dependem desta renda?) ( ) Nãosabe ( ) Não quer responder

Está trabalhando: ( ) Sim ( ) Não ( ) Aposentado ( ) Não sabe ( ) Não quer responderProfissão:

_____

Se sim, é autônomo? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Não quer responder

Filhos: ( ) Não ( ) Sim, quantos?_____Qual idade?_____( ) Não sabe ( ) Não quer responderTem plano de saúde? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Não quer responder

DADOS CLÍNICOS

Você é portador do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Não quer responder

Recebeu o diagnóstico de um profissional de saúde? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Não quer responder

Serviço utilizado: ( ) Público ( ) Privado ( ) Ambos ( ) Não sabe ( ) Não quer responder

Alguém mais no seu domicílio é portador do HIV? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe ( ) Não quer responder Grau de parentesco: _____

EXCLUSIVO DO PESQUISADOR

Entrevistador:_____

Data:__/_____/_____Cidade:_____